Talamo, R. Il cantone malato. Lugano 200.

CAPITOLO I

Le caratteristiche generali

1. LE CONDIZIONI IGIENICHE

«Decadenza del paese»; con queste parole le autorità governative comi tarono nel 1857 il saldo demografico negativo di quell'anno: 3.090 decessi e 2.571 nascite [9, 1857/125]. Cifre che sintetizzavano freddamente il male sociale delle classi popolari ticinesi, soprattutto se considerato dal punt vista dei disagi igienici e alimentari. La consapevolezza di questo stato di andò vieppiù rafforzandosi nelle menti di governanti e legislatori durante i mi decenni del secolo scorso, consolidandosi nel contempo l'idea che salvag dare la salute dei cittadini fosse uno specifico compito dello Stato, dal quale ci si poteva esimere oltre.

La prima impressione per chi, intendendo studiare queste realtà, n mano alla documentazione esistente, è di trovarsi di fronte ad un materiale l noso e frammentario. A serie di anni ben documentati fanno riscontro vu silenzi; e in genere sono pressoché assenti dati affidabili per quantificare s sticamente determinati fenomeni. Si tratta per lo più di testimonianze pa o riferite a realtà locali e specifiche e perciò non sempre generalizzabili. Ber ficilmente infatti le rilevazioni compiute per il distretto di Mendrisio potreb avere un medesimo riscontro per i distretti alpini e una simile differenza po be riscontrarsi tra un piccolo e isolato villaggio rurale di poche centinaia di tanti e un agglomerato urbano come Lugano dalle dimensioni più consist Sembra perciò opportuno assumere le informazioni rispettando queste va regionali, senza però perdere di vista i riferimenti generali.

Per comodità di esposizione si è ritenuto di trattare l'argomento ten particolarmente presenti:

— l'alimentazione;
— l'igiene delle abitazioni, dei villaggi e dei centri abitati;
— i sistemi fognari e i sistemi di approvvigionamento di acqua potabile.

Per quanto riguarda la documentazione sono basilari gli scritti del Gl ghelli e del Franscini, dei quali si farà più volte menzione [62 e 59].

In via preliminare si può asserire che il tenore di vita delle classi popolar nesi appariva decisamente misero. L'impressione di grande povertà era già espressa dai diversi viaggiatori d'Oltralpe che ebbero modo di visitare le n contrade nel '700.

A causa delle asperità e irregolarità del territorio, una parte piuttosto ridotta della superficie poteva essere sfruttata. Un quarto del territorio cantonale era infatti improduttivo; e sulla porzione rimanente, in base ai dati del censimento federale delle aziende agricole del 1905, prevalevano le aree boschive e le pasture. Le coltivazioni erano praticate solo su di uno spazio di poco superiore al 10% della superficie produttiva totale [44, 112]. L'attività agricola era condotta con tecniche arretrate e poco redditizie. Scarsi erano gli stimoli al rinnovamento e la penetrazione e diffusione di conoscenze agronomiche e tecniche. La proprietà risultava estremamente parcellizzata e spesso notevoli erano le distanze che separavano gli agricoltori dai fondi. Questo complesso di circostanze determinava una forte dipendenza del Cantone dagli approvvigionamenti di derrate agricole estere e alimentava da tempo un consistente flusso emigratorio, per lo più stagionale, in direzione soprattutto dell'area padana. Per chi rimaneva in patria, soprattutto i vecchi, le donne e i bambini, alla durezza dei lavori campestri non sempre facevano riscontro proventi adeguati. Nel Mendrisiotto, ad esempio, dove la natura del territorio era più favorevole che altrove, dove l'agricoltura era condotta con metodi più razionali, la pressione sulla terra era tale che la gente appariva «consunta dalla miseria e coperta di stracci»[62, 53]. La miseria e la durezza dei lavori poteva facilmente essere letta sui volti della gente e nelle costituzioni fisiche sovente deperite e dall'aspetto poco sano. Il Franscini riferiva dei «vispi e cari fanciulli» dei villaggi ticinesi che, divenuti adulti, apparivano «tutt'altro che begli uomini, colpa gli stenti ed i disagi della vita in patria e fuori» [59, I/180].

La durata media della vita non era molto elevata, soprattutto a cospetto degli indici di altri Stati. Su di essa influivano negativamente le alte cifre della mortalità infantile e le scarse possibilità di raggiungere età avanzate. I dati sono del Franscini. Su 43.286 individui che nel 1808 formavano la popolazione maschile del Cantone solo 7.860, il 18%, erano quelli appartenenti alla fascia di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Altrove, a detta dell'autore, questo indice si aggirava attorno al 20%. Nella successiva fascia, dai 60 agli 80 anni, si contavano 2.472 persone, il 5,7%, quando in altri Stati si raggiungeva solitamente il 7%. In un saggio relativamente recente il Ceschi, avvalendosi di alcuni dati raccolti nel 1849 dal dottor Carlo Avanzini, ha potuto confermare per il Mendrisiotto la «poca longevità di quella popolazione». Dei 5.520 abitanti di nove comuni del distretto solo 348, il 6,3%, superavano i 60 anni e l'Avanzini faceva notare che la vita delle donne era più breve di quella degli uomini; il pesante fardello dei lavori agricoli era la principale causa del loro precoce invecchiamento [45, 74].

L'analisi dei regimi alimentari popolari [73 e 75] può fornirci qualche ragguaglio per spiegare una realtà che, già a parere dei coevi, appariva tanto desolata. Da uno sguardo preliminare del materiale a nostra disposizione si può asserire che anche per le terre ticinesi il regime dietetico era contraddistinto da uniformità e monotonia. Se si tralascia la situazione di alcune regioni in cui era possibile integrare le diete con qualche prodotto dell'allevamento, scarsa era la varietà di sostanze sufficientemente nutrienti. Si può parlare di sottoalimentazione diffusa o di fame endemica anche in tempi normali, non funestati da avverse congiunture economiche e da carestie. Nonostante l'esistenza di alcune differenze

dai regimi alimentari dell'area lombarda, in particolare per ciò che riguarda un minore consumo di mais nella nostra regione, si può concordare con il giudizio espresso dal Della Peruta, il quale ha messo in rilievo come il «bilancio nutritivo della grande maggioranza delle popolazioni lombarde era in maggiore o minor misura carente dal punto di vista dell'apporto calorico, proteico e vitaminico» e come questa condizione influisse «drammaticamente sulla mortalità e sulla morbilità» [52, 313].

Alla base delle diete popolari predominavano i cereali (tra i quali il frumento non godeva di una posizione di rilievo) ed i legumi; e, in particolare all'inizio del XIX secolo, si menziona anche la castagna come un genere di larghissimo consumo. Per contro la carne fresca era praticamente assente dai regimi dietetici popolari; si mangiava questo prodotto solo in via eccezionale e solitamente in occasione di festività.

Nei suoi studi il Lurati ha osservato che nel paese il mais penetrò con ritardo ed assunse un primato tra i generi di consumo popolare solo nei primi decenni del secolo scorso; ed anche in questo periodo la polenta continuò spesso ad essere compota di misture. Il suo consumo era senz'altro maggiore nel Mendrisiotto, unico distretto del Cantone in cui si accenna a qualche caso di pellagra. Altrettanto lenta fu la diffusione del riso, riservato prevalentemente alle mense delle classi più agiate. La patata penetrò progressivamente nelle terre ticinesi tra il 1780 e i primi anni dell'Ottocento, e alla sua introduzione è legata la rottura del monotono «rapporto dualistico grani-castagna».

Circa le particolari componenti dei regimi alimentari possiamo disporre di qualche breve notizia fornitaci dal Ghiringhelli che si riferisce ai primi anni del secolo e testimonia soprattutto la povertà delle diete e la loro negativa influenza sulla salute dell'organismo umano. Egli scriveva che «i cibi del contadino sono molto pesanti» e tra questi elencava polenta, castagne, miglio, patate, minestre di piselli, fagioli, pane di segale. Il riso, la carne e il pane di frumento erano delle vere rarità e anche sulle tavole dei cittadini più notabili il pane era «per due terzi fatto di frumento e per un terzo di segale» [62, 74].

Più circostanziato è il quadro alimentare che ci ha fornito il Franscini e che si riferisce agli anni '30, nel quale si possono riscontrare alcuni elementi di miglioramento rispetto ai tempi avversi in cui scrisse il Ghiringhelli. Il merito di questo autore è di aver descritto le diverse diete tenendo conto delle differenze regionali e sociali. Le sue informazioni riguardano infatti tre tipi di vitto: del contadino, dell'alpeggiatore leventinese e del cittadino [59, I/184-8]. La dieta più comune era quella del contadino, il quale generalmente consumava tre pasti al giorno e nei periodi di maggior lavoro anche quattro. A colazione si cibava con una porzione di polenta di mais o di mistura (pietanza che si impose in sostituzione alle polte di miglio e di grano saraceno che erano invece consumate nei primi anni del secolo) oppure, «alla foggia del povero irlandese», mangiava patate bollite. Il pranzo si componeva di pane di segale e patate accompagnate solitamente da formaggio o ricotta. Il pane di granoturco era conosciuto praticamente solo nel Mendrisiotto; e «onninamente disusato» era ormai l'impiego della farina di orzo o di castagne per la panificazione. A cena il contadino ticinese si cibava con minestre di riso e patate o con ortaggi come le rape e i fagioli, ma spesso anche con semplici minestre di orzo o di panico, mentre le famiglie

più povere erano costrette «a cenare non con altro che con castagne o con pomi di terra». Un quarto pasto aveva eventualmente luogo tra le tre e le quattro pomeridiane ed era a base di pane con «cacio o mascarpa». Solo le famiglie contadine più agiate, che potevano permettersi di macellare un maiale o un bovino, avevano la possibilità di consumare carne, generalmente sottoforma di insaccati.

Il vitto dell'alpeggiatore leventinese era definito abbondante, di buona qualità e più nutriente per la presenza dei prodotti dell'allevamento. Latte, panna, formaggio, ricotta, burro e «mascarpa» erano i generi che componevano la dieta giornaliera dell'alpigiano e che egli consumava generalmente con polenta e con pane. Questa era comunque una situazione particolarmente privilegiata, e lo stesso Franscini avvertiva che sulle pasture di altre regioni del Cantone il vitto «non è né scarso né cattivo, ma è generalmente riputato inferiore a quello (...) descritto».

Ben diversi erano i prodotti che comparivano sulle mense dei ceti sociali più ricchi. Qui il consumo di carne, sia bovina che suina, e di selvaggina e pollame rappresentava la regola, e comparivano in abbondanza anche le uova ed i pesci che solitamente i contadini riservavano al mercato, proprio per le classi più abbienti.

Tra le bevande il vino era estremamente diffuso in tutte le classi sociali ed il suo consumo, al quale si abituavano anche i bambini, assumeva dimensioni allarmanti, ma anche l'acquavite compiva rapidi quanto nefasti progressi.

Nelle società preindustriali i capricci delle congiunture economiche incidevano direttamente e rapidamente sull'alimentazione. Le diete già di per sé misere, peggioravano quantitativamente e qualitativamente in tempi di carestia e in quelle circostanze le genti dovevano ingaggiare vere lotte per la sopravvivenza, come nei calamitosi anni 1816-17, durante i quali si ha testimonianza che larghi strati della popolazione, dopo una serie di magri raccolti, si vide costretta ad alimentarsi con radici.

Nei documenti esaminati e soprattutto nei rapporti medici si cita sovente la pessima qualità di molti generi alimentari consumati. Questa circostanza induceva i medici del tempo ad individuare un rapporto di causa-effetto tra disordini alimentari e sviluppo di malattie. Sebbene nelle leggi organiche comunali esistessero prescrizioni per la nomina di commissioni annonarie incaricate di vigilare sulla salubrità di cibi e bevande, le trasgressioni sfuggivano ai controlli frequentemente e circolavano con facilità generi avariati e nocivi alla salute pubblica. Erano soprattutto i ceti più poveri a consumare cibi scadenti; e praticamente ogni anno i sanitari notificavano in più parti del Cantone affezioni gastro-enteriche o gravi forme dissenteriche le cui manifestazioni assumevano spesso proporzioni epidemiche. Nel 1849 il dottor Paolo Pellanda inviò un rapporto alla commissione cantonale di sanità informandola che nei comuni di Intragna, Golino e Pedemonte serpeggiava una grave dissenteria epidemica che in breve tempo uccise trenta bambini e due persone adulte. I sintomi erano acuti e caratterizzati da forti e costanti dolori intestinali e in molti individui da «frequenti (...) dejezioni di muscosità mista a sangue, in taluni di puro sangue dapprima indi d'una sierosità sanguinolenta, qual sarebbe lavatura di carne». Tra i fattori eziologici il sanitario elencava l'assunzione di «cibi grossolani e mal

digesti» e notava che «ne furono immuni gli agiati e i ben nutriti» [11/730. Golino, 6.10.1849].

I richiami governativi alle autorità locali si intensificarono soprattutto verso la metà del secolo nell'intento di esigere un controllo attento, sovente però senza un riscontro pratico, sui macelli, i panettieri, i pizzicagnoli e i mercati di frutta, legumi e prodotti dell'orticoltura. Allo stesso modo si deprecavano i pessimi metodi di cottura del pane e l'uso di farine guaste, mal conservate o non sufficientemente stagionate, a causa della necessità che spingeva molti contadini ad anticipare i raccolti per potersi in qualche modo nutrire. Nel 1849 un articolo apparso sull'«Almanacco del popolo ticinese» denunciava la cattiva abitudine di ammassare per lungo tempo le farine in ambienti umidi e poco ventilati, dove facilmente degeneravano, fermentavano e acquistavano «sapore ed odore empireumatico»; e di conseguenza tornavano «di mala influenza all'economia della vita, producendo varie affezioni epidemico-popolari, come febbri gastriche, tifoidee, ecc.» [13, 1849/155].

La quasi totale assenza di controlli facilitava anche la circolazione sui mercati di carni guaste e di pessima qualità. In quel periodo non esistevano nel Cantone macelli comunali dove il bestiame fosse sottoposto a visite veterinarie. Le macellazioni venivano effettuate privatamente senza nessuna garanzia di ordine igienico e sanitario. «Si macellano per tutto bestiuole piccolissime e di pessima qualità» [59, I/188], scriveva il Franscini a proposito della diffusa abitudine degli allevatori di sbarazzarsi presto e con profitto di quei vitelli e capretti che non intendevano allevare. Nel 1845 anche la commissione cantonale di sanità denunciava l'uso frequente di vendere carni di vitelli nati da pochi giorni e non abbastanza maturate. Ma quello stesso anno erano pervenute alle orecchie dei membri della commissione sanitaria voci attendibili sull'esistenza di un traffico clandestino, proveniente dagli Stati confinanti e specialmente dalla Lombardia, di carne infetta ed appartenuta a «animali morti o per malattia accidentale o per epizoozie di natura maligna». Occorreva una maggiore sorveglianza alle frontiere e un controllo più severo delle fedi di sanità per impedire che si introducessero nel nostro Cantone «animali già ammalati di diverse malattie», che «si macellano dopo vendendo le carni in diversi paesi del Mendrisiotto, del Luganese e d'altri distretti» [1.1/1106. Bellinzona 18.11.1845]. Si ha anche notizia che dall'estero si importavano clandestinamente notevoli quantità di vino adulterato e di scadente qualità.

Gli sforzi per limitare questi disordini e la situazione di anarchia esistente nell'ambito degli approvvigionamenti annonari si fecero molto più intensi in occasione della minaccia di gravi epidemie, in particolare quelle di colera, che, a scadenze più o meno regolari, interessarono alcune regioni del nostro Cantone. Nel clima di fervore suscitato dall'allestimento di tutte le misure profilattiche per salvaguardare il paese dal morbo, si sottolineava con vigore la mancanza di necessarie garanzie di ordine igienico e lo stato di insalubrità di cibi e vivande, situazione che valse, al di là delle circostanze contingenti, a gettare le basi per rivendicare una più sollecita polizia igienica. Nella circolare del 4 ottobre 1831 redatta dalla commissione sanitaria e rivolta al popolo ticinese erano contenute norme e istruzioni per preservare il paese dal flagello del «dominante morbo orientale». Tra queste riportiamo lo stralcio riguardante gli

alimenti, perché in esso troviamo riassunti a vive tinte i disordini annonari di cui si è detto.

«Sappiate pertanto, che devon essere da voi proscritte tutte le frutta aspre, acquose ed immature, tutto ciò che passa facilmente alla fermentazione, od è di difficile digestione come la birra, il latte inacidito, i funghi, i pesci salati, le vivande grasse, il pane il vino le carni di cattiva qualità, l'uso soverchio di bevande spiritose, e di cibi calidi aromatici. L'autorità locale quindi dovrebbe farsi carico singolare della sorveglianza delle bettole, osterie, macelli e vettovaglie. Nocivissimo è il pane acido, malcotto, e glutinoso. Il carbone, la ruggine, e molti semi acri e narcotici rendono il grano, se da quelli non si separa, assai sospetto e capace a produrre malattie spasmodiche e perniciose. Sospettissimo il vino che s'introduce dall'estero nel Cantone in certe epoche alla sua decomposizione favorevoli, ed ordinariamente è mascherato o guasto od a venefiche sostanze associato, come non poche volte noi stessi il vidimo. Le carni d'animali morti da sé o presi da consunzione, o affetti da tubercoli, che spesso si rinvengono nel fegato, nella milza, né polmono, o da ulceri, da vermi, da bolle d'aria nelle fauci o nel petto, e da tant'altri organici malori, generano febbri putride e malignissime. I vitelli immaturi, la carne freschissima, e le bestie troppo magre, che non danno che fibre durissime, e membrane scipite riescono tenaci ed indigeste. I condimenti, i pesci ed altre sostanze fracide, e le frutta acerbe o putride smerciate in gran copia sulle nostre piazze a buon mercato fanno stragi ne' miserabili» [I.1/719. Lugano, 4.10.1831].

«Il viaggiatore — annotava il Ghiringhelli — (...) vien tratto a giudicare di una diffusa grande miseria dall'abbigliamento rozzo e stracciato, in cui il contadino gli appare, dalla sua magrezza, dal color bruno della pelle, dalla barba lunga a pollici, ecc.» [62, 67]. In effetti l'igiene personale era molto trascurata e non rientrava nell'ambito delle abitudini popolari. Il non cambiare frequentemente d'abito, l'indossare stoffe grezze, pesanti e sporche era all'origine di irritazioni e affezioni della pelle. Scriveva il Franscini che «il bagno (...) è pochissimo in uso fra la nostra classe civile ed è quasi del tutto sconosciuto al popolo delle contrade non lacuali» [59, I/181]. Questo giudizio trova più conferme: «la mondezza del corpo e degli abiti non è la migliore qualità della nostra popolazione» [5, mag. 1845/427], osservava nel 1857 la commissione sanitaria proponendo di impiantare nei maggiori centri del paese degli stabilimenti di bagni pubblici, ma in quello stesso anno si doveva anche ammettere che vi era ancora molto da fare «per spargere nel popolo l'istruzione igienica, incarnandola con le di lui abitudini» [9, 1857/136].

Questa scarsa sensibilità igienica può in parte spiegare anche il miserevole stato in cui versavano le abitazioni popolari. Pur esistendo notevoli differenze regionali, parecchi erano i tratti comuni. Si può infatti asserire che le abitazioni popolari erano sovraffollate, poco pulite, umide, prive di servizi igienici, senza luce, con scarse possibilità di ventilazione; gli animali vivevano nelle vicinanze o addirittura in coabitazione con gli uomini. «Nessun maiale della Svizzera tedesca entrerebbe in una delle abitazioni degli uomini di qui» [62, 53], affermava negli ultimi anni del XVIII secolo il Bonstetten. Giudizio che va ridimensionato, poiché l'autore confederato estese a tutto il Ticino una situazione che aveva osservato in zone estremamente povere come la Val Verzasca, la Vallemaggia e la Val Onsernone.

A distanza di pochi anni il Ghiringhelli riferiva semplicemente che le case costruite nelle parti più elevate del Cantone erano qualitativamente migliori e più curate di quelle «d'aspetto molto misero situate in pianura». La maggioranza delle case rurali era stata costruita con poca o addirittura senza calce e «comodità, simmetria, pulizia non [erano] le loro caratteristiche» [62, 69]. Sulle condizioni di sovraffollamento sono preziosi i calcoli del Franscini. Nel 1836 esistevano approssimativamente nel paese, che allora contava 113.000 abitanti divisi in 20.659 famiglie, 18.200 case e 24.300 stalle. Ciò corrispondeva in media a 88 case ogni 100 famiglie, ma questo indice diminuiva a sole 55 case ogni 100 famiglie nei centri di Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio, mentre in Leventina ordinariamente due famiglie alloggiavano sotto lo stesso tetto.

Per quanto riguarda la qualità delle abitazioni si può osservare che la maggior parte era di antica costruzione; nel periodo compreso tra il 1803 e il 1831 furono edificate solo 1.400-1.500 case nuove, cioè circa 50 all'anno, e ne furono abbattute circa 600 (si tenga presente che la popolazione in quel periodo era aumentata di oltre 20.000 anime). Rispetto ai primi anni del secolo, diverse innovazioni e miglioramenti erano stati introdotti, anche se era pur necessario confessare che «le camere mal soffittate, le cucine senza camino e illuminate da un tizzo non [erano] in piccol numero» [59, I/195].

Alla comodità e ampiezza delle abitazioni della borghesia cittadina faceva riscontro l'angustia delle case rurali. Nel Sottoceneri, accanto alle case coloniche del Mendrisiotto, «non vaste né magnifiche, ma graziose e di buon gusto», si ergevano quelle dei villici, basse e scarsamente illuminate, dove non era infrequente vedere «allo stesso livello e contigue la cucina, la stalla» e i letamai ammonticchiati vicino all'uscio. Nel Sopraceneri le dimore degli abitanti insediati sulle pianure e nel fondo delle valli del Ticino e della Maggia erano costruite in pietra. Di dimensioni molto modeste e con i soffitti bassissimi, spesso mancavano di camino e si presentavano «d'aspetto meschino e ingrato». Anche le case della Verzasca, della Vallemaggia e della parte inferiore della Val di Blenio si caratterizzavano per le loro ristrette dimensioni, mentre a Biasca il Franscini osservava che «appar minore la cura per l'abitazione degli uomini che per quella delle bestie». Infine in Leventina si erano costruite case in pietra e in legno, ma, ad eccezione di quelle situate nella parte superiore della valle che erano «mediocremente capaci», anche qui predominavano le ristrette dimensioni.

Numerose le testimonianze sull'insalubrità dell'ambiente che veniva a crearsi all'interno delle abitazioni rurali, sia per la generale mancanza di pulizia, che per l'aria viziata e corrotta dal fumo e dalle esalazioni delle immondizie domestiche. Infatti lo scarso rispetto di elementari norme igieniche e la tenace sopravvivenza di inveterate abitudini, come il credere «utilissima cosa, il più che sia possibile impedire il cambiamento dell'ambiente» [I.1/1106. s.l., 1839], non potevano che perpetuare queste situazioni. Così il Franscini osservava che nelle case leventinesi durante la stagione invernale «quando si scalda molto la stufa, e vi si dorme e mangia e beve e lavora, e mai o quasi mai apronsi le invetriate, vi domina un tanfo insopportabile per chiunque non è avvezzo, nocivo alla salute di chicchessia»; e vi era da notare che «il paesano leventino è de' men male alloggiati delle cisalpine regioni» [59, I/197-8].

Stretta quindi la connessione tra malsani ambienti abitativi e manifestazioni morbose. Nel 1836 il dottor Cipriano Chicherio attribuiva lo sviluppo di una febbre nel comune di Airolo alla «scarsezza delle abitazioni rispetto alla popolazione: per cui numerose famiglie stanno in stanze anguste ed eccessivamente riscaldate, dandosi poca o nissuna premura di rinnovare l'aria di tali ambienti» [1.1/846. Airolo, 3.6.1836]. Qualche anno più tardi, nel 1844, lo stesso sanitario tentava di spiegare l'eziologia di una febbre tifoidea che serpeggiava a Chironico, facendo ancora riferimento alle inadeguate condizioni abitative.

«In quanto alle cause — annotava il medico — che hanno potuto favorire lo sviluppo di questo malanno in un clima per altro salubre, non si saprebbe assegnarne altra, che la poca nettezza delle persone, e la somma angustia ed impulizia delle abitazioni. E per verità, generalmente parlando, indotta questa popolazione dal costume, od astretta da povertà ad abitare in piccoli casolari di legno, consistenti in una o due stanze riscaldate all'uopo mediante stufa, le di cui finestre destinate ad ammettere una scarsa luce, anzicché all'opportuna ventilazione; divisa dal suo bestiame, che giace nelle sottoposte stalle, da un suolo d'assi in alcuni luoghi vecchi e mal connessi, ed avente in prossimità i letamai; questa popolazione dissi, vive la massima parte della stagione jemale in un ambiente zuppo di emanazioni putride».

Nel rapporto il Chicherio aggiungeva che gli individui maggiormente colpiti dalla malattia erano le donne e i fanciulli, perché «pella loro condizione dimorano di più nelle case» [ibid. Bellinzona, 24.10.1844]. Tra le nocive abitudini popolari che proprio in questi anni medici e igienisti additarono con insistenza sempre maggiore, vi è da annoverare quella di rifugiarsi nelle serate invernali con bambini e neonati nelle stalle, per supplire con il calore degli animali alla scarsità di legna. Le occasioni di coabitazione con gli animali domestici erano oltremodo frequenti: nel 1835 il commissario governativo di Lugano denunciava il «barbaro costume di pressoché tutti i comuni rurali di accomunare il soggiorno delle bestie con quello degli uomini» [ibid. Lugano, 1.11.1835]. E, per fornire un altro esempio, nel 1836 il dottor Chicherio, nel tentativo di debellare una «febbre nervosa» ad Airolo, non mancò di proibire tassativamente che si tenessero «nelle stanze ove si dorme galline, e bestiame nelle stalle immediatamente sottoposte alle stesse» [ibid. Airolo, 24.6.1836]. Ancora nei primi decenni del XX secolo il Tamburini tratteggiava lo stesso quadro ben fosco delle case contadine [93, 13].

Le notizie sulle abitazioni popolari cittadine sono scarse, ma si ha motivo di credere che anche qui regnassero pessime condizioni igieniche, determinate da sovraffollamento, che nei centri urbani era maggiore rispetto alle campagne, e dalla mancanza di servizi igienici. Una significativa testimonianza ce la fornisce il dottor Basilio Bonardi, che verso la fine del secolo scorso ritraeva molto attentamente le pessime condizioni di vita nei quartieri popolari luganesi. «Casupole ningherline ed oscure alte e misere, o casaccie puzzolenti, ricordo di più miserevoli tempi, appiccicate sul fianco una dell'altra e voltantisi il dorso e sostenentisi reciprocamente, vere negazioni non del buon senso architettonico, ma del senso comune di ogni regola elementare dell'igiene: è in esse che si accalca buona parte della popolazione più povera della città nostra» [35, 50].

Con queste parole nell'agosto del 1831 il commissario governativo del Luganese si rivolgeva ai membri della commissione cantonale di sanità: «Dappertutto veggonsi letamai, ammonticchiamenti di immondizie le più corrotte (...): dappertutto gli scoli delle stalle si lasciano scorrere sulle strade, e nelle strade pure si gettano le spazzature delle case. Non havvi alcuna premura né diligenza nelle Municipalità onde vincere un tal disordine: e la legge rimane dappertutto inosservata» [1.1/728, Lugano, 16.8.1831]. Dal profilo igienico, dunque, anche l'aspetto dei centri abitati e dei villaggi ticinesi non doveva essere dei più allegri. Il Ghiringhelli osservava che nel passato il bisogno di stringersi per reciproca difesa e la scarsità di sorgenti di acqua potabile avevano presumibilmente determinato un sistema di costruzioni molto addensate in uno spazio relativamente ristretto. All'interno, trasgredendo le ordinanze comunali sulla pulizia di strade, piazze e luoghi pubblici, regnavano la più diffusa sporcizia e le più deprecabili condizioni antiigieniche. In genere i più piccoli paesi montani mancavano di sistemi fognanti, mentre i centri più grossi e le città disponevano di fogne, cloache e canali per il convogliamento delle acque luride così imperfetti, insufficienti e mal costruiti da inquinare il terreno circostante e il sottosuolo. Del resto il fatto che la maggior parte delle abitazioni difettasse di servizi igienici si ripercuoteva direttamente sulla pulizia dell'intero abitato. I rifiuti e le immondizie domestiche venivano abbandonate sulle strade dove, a causa dell'inefficienza dei servizi di nettezza comunale, rimanevano per lungo tempo. Da addebitare a mancanze di servizio anche la poca solerzia ed i ritardi con cui venivano spurgate e ripulite le cloache e i canali fognanti, ed a incuria l'abitudine di ammassare all'interno degli abitati rurali mucchi di letame che emanavano miasmi insopportabili e soprattutto perdevano le sostanze liquide che impregnavano il terreno delle strade pubbliche sovente non lastricate.

I numerosi richiami alla nettezza che si susseguivano insistentemente stanno a dimostrare come dovessero essere frequenti le trasgressioni. Così ad esempio nel 1813 la municipalità di Lugano emanò un proclama per sollecitare la pulizia delle strade, rinnovando tra l'altro la «proibizione di rovesciare dalle finestre, o dalle porte delle case sulle pubbliche strade, (...) cosa alcuna, molto meno acqua sporca, orina, od altre immondezze sì di giorno che di notte» [2.3, 19.8.1813/71]. Similmente il 31 agosto 1836 il medico delegato del circolo di Agno, incaricato dal Consiglio di Stato di visitare i comuni del circondario per verificare se le misure profilattiche ordinate per preservare il paese dal contagio del colera fossero state messe in pratica dalle autorità municipali, riferiva di aver rilevato molte inadempienze, a causa soprattutto della consuetudine di «gettare dalle finestre le orine, che rimanendosi in parte sulle strade, tramandavano mefitiche e nocive esalazioni» [1.1/719. Agno, 31.8.1836]. In condizioni veramente indecenti fu rinvenuto lo stesso anno il comune di Bissone ispezionato dai dottori Fraschina e Landthaler. Dopo aver percorso accompagnati dal sindaco le strade del paese, i due sanitari comunicavano di aver «riscontrato la massima impolizia in pressoché tutte le contrade e vicoli»; rimarcando in particolare come «siffatti vicoli sembrano piuttosto altrettanti depositi delle più sozze immondezze, che strade di comunicazione tra una casa e l'altra. (...) In tutto il paese [che in quegli anni contava poco più di 300 abitanti] non vi sono forse più di tre o quattro latrine, e serve a un tale uso il di dietro delle loro case, o qualunque siasi viottolo, cosiché da ogni parte esala un puzzo al sommo ributtante» [1.1/729. Lugano, 9.8.1836].

Le difficoltà di eliminare razionalmente i rifiuti dei centri abitati non possono essere disgiunte da un'analisi dei sistemi di approvvigionamento idrico per usi domestici e di potabilità esistenti in questo periodo nel Cantone. Anche in questo caso le notizie in nostro possesso sono lacunose e il corpo principale della documentazione si riferisce agli ultimi decenni del secolo scorso, quando proliferarono i progetti per l'impianto di acquedotti nei comuni ticinesi; realizzazioni eseguite nella consapevolezza di quanto fossero insalubri gli antichi metodi. Proprio sulla base di questa documentazione possiamo affermare che la popolazione ticinese, nel periodo considerato, consumava con estrema facilità un'acqua che non rispondeva ai necessari requisiti di potabilità, rivelandosi contaminata da molteplici sostanze tra le quali le materie organiche in decomposizione.

All'impurezza dell'acqua, ad esempio, il Ghiringhelli attribuiva la presenza del gozzo in alcune regioni del Cantone; e a distanza di qualche anno il Franscini riprendeva queste asserzioni riferendo della pessima acqua che si beveva a Biasca dove questa malattia dominava endemicamente. Verso la metà del secolo anche le autorità governative si mostravano preoccupate per la «deficienza di buone acque potabili nella maggior parte dei comuni» [9, 1855/192]. Nel 1857 si annoverava tra le principali incombenze dell'autorità sanitaria quella di far analizzare le acque potabili nelle località in cui infierivano determinate malattie e di, «ove sia mestieri, ordinare l'erezione di fontane pubbliche» [9, 1857/135]. Ben poco fu comunque realizzato in questo periodo e solo qualche comune costruì fontane alimentate con acque di sorgente, ma questi rimasero nel complesso episodi isolati. A titolo di esempio la municipalità di Mendrisio provvide nel 1842 a attivarne una, poiché l'acqua del borgo era palesemente infetta.

A parte il caso di alcuni paesi montani dove si traeva l'acqua direttamente da torrenti e ruscelli, si ha motivo di credere che nel Cantone l'uso dei pozzi fosse pressoché la regola. Il Ghiringhelli osservava in merito che agli inizi del secolo fontane perenni per uso sia pubblico che privato esistevano solo in Leventina; in genere «i villaggi traggono l'acqua dai ruscelli di montagna, i borghesi dai pozzi». Praticamente ogni casa possedeva un proprio pozzo e in pianura era raro «non trovare acqua ad una profondità di quattro o cinque braccia» ed in molti luoghi ancor più in superficie [62, 71-2].

Si trattava comunque di metodi esposti facilmente a occasioni di inquinamento da materie esterne, tra le quali in particolare quelle derivanti dai materiali di rifiuto. Così si trovavano con frequenza disciolte o sospese nell'acqua delle materie nocive, contenenti microorganismi attivi e germi patogeni, capaci di agire in modo più o meno diretto sull'organismo umano. In un opuscolo di fine secolo sulle acque potabili di Locarno l'ingegnere Giovanni Rusca contemplava tra i fattori inquinanti quelli derivanti dalle acque luride, «da immondizie di strada o di case d'ogni natura, da materie cloacali, da avanzi di lavatoi, di bagni, di alimenti, da acque saponacee, da resti d'animali morti (topi, vermi, ragni ecc.), da (...) legnami corrotti, da rifiuti di opifici, gazometri ecc.». Inoltre riferiva che era un fatto ormai assodato che per mezzo dell'acqua si introducevano nell'organismo dei parassiti come le uova di tenia o altri microbi capaci di cagionare malattie infettive come «il colera, il tifo addominale, il carbonchio, la malaria e le dissenterie» [91, 8].

Diverse le denunce di gravi forme di inquinamento dei sistemi idrici. Nel 1836, ad esempio, mentre in alcune località dei distretti sottocenerini infieriva il colera, l'ufficiale del giorno di Mendrisio Giuseppe Baroffio informava la commissione sanitaria che erano stati trovati nell'acquedotto che forniva l'acqua alla piazza «già tre cani morti ed in putrefazione» [1.1/721. Mendrisio, 31.7.1836]. Nel 1884 la municipalità di Grumo inviò una lettera al dipartimento di igiene con la quale chiedeva che le autorità comunali di Torre fossero costrette a deviare l'acqua che usciva dal serbatoio di un acquedotto situato nel centro del paese, la quale correndo lungo la strada comunale e attraversando una cunetta si gettava in una roggia, la sola che alimentava il loro paese. In questo modo, facevano notare i petenti, il comune di Grumo era costretto a ricevere un'acqua «immonda putrefatta e insalubre», perché «gli abitanti di Torre vanno a lavare ad ogni ora della giornata, in detta roggia, siano pure abiti o lingerie di ammalati, o morti, e lasciati pure ivi alcune ore deposti. Notisi pure — aggiungevano i municipali — che lungo la detta cunetta, vi pascolano continuamente majali e bovine; e così formano, collo sterco, un ammasso di melma in detta acqua, oltre le altre immondizie d'ogni sorta che vi si rinvengono nella roggia maggiore» [1.1/145. Grumo, 27.8.1884].

Tra i diversi sistemi di approvvigionamento idrico furono soprattutto i pozzi ad essere sottoposti alle più accese critiche di medici e igienisti, i quali denunciavano l'estrema facilità con cui poteva avere luogo l'inquinamento. Una delle maggiori cause risiedeva nello stato di stagnazione in cui veniva a trovarsi l'acqua nella conca, soprattutto perché i tempi di rinnovamento erano lentissimi. Ciò determinava l'accumularsi di uno strato di fanghiglia impura, ricca di microorganismi attivi. Quest'acqua già impura era assoggettata inoltre all'azione dell'inquinamento esterno, poiché dall'apertura poteva penetrare ogni genere di sostanza; e in particolare, osservava l'ingegnere Rusca, «oltre all'aria e sue impurezze, vi ponno altresì cadere animali, oggetti sudici, secchie non pulite»; e nelle stagioni secche, quando l'acqua nella conca era poco profonda, diveniva «assolutamente impotabile» [91, 17]. Anche le pareti interne dei pozzi, soggette agli agenti atmosferici e sovente trascurate dal punto di vista della pulizia e della manutenzione, rappresentavano un veicolo di contaminazione. I maggiori pregiudizi alla potabilità, anche se di ciò all'epoca non si aveva una precisa consapevolezza, erano però costituiti dall'inquinamento del sottosuolo, che, con un'azione lenta, ma progressiva, poteva trasmettersi alle falde acquee sottostanti infettandole irrimediabilmente. Secondo il Rusca poteva accadere con relativa facilità che una fossa nera lasciasse disperdere nel sottosuolo il contenuto, che «cola poi lungo le pareti esterne delle murature del pozzo, raggiunge il fondo e vi penetra» oppure, essendo il terreno circostante saturo di immondizie, le acque piovane attraversandolo avrebbero trasportato «le materie organiche e i germi al fondo» [91, 18].

Da questo punto di vista l'efficienza dei sistemi di fognatura per l'eliminazione delle acque luride e delle sostanze di rifiuto era determinante. Ma, come si è già accennato, anche in questo ambito la situazione era molto arretrata e non presentava nessuna garanzia di ordine igienico. Nei comuni ticinesi e soprattutto nei centri urbani esistevano impianti di fognatura vecchi, inadeguati e mal costruiti, composti da una disordinata e imperfetta rete di canali e condot-

ti mal saldati e dalle pareti permeabili, che lasciavano facilmente fuoriuscire le sostanze luride che impregnavano il terreno circostante. Nel 1877 la conferenza medica organizzata a Lugano per approntare i mezzi profilattici per far fronte a una grave epidemia di vaiolo che serpeggiava da diversi mesi in città, aveva individuato tra i fattori che ne avevano determinato lo sviluppo proprio la «scarsità e quasi totale mancanza di acque potabili correnti» e la «mancanza di pozzi neri e cloache, dove siano raccolti gli scoli e le materie impure e fetenti, ed onde possino essere estratte senza fastidio e danno della pubblica igiene» [87, 19]. E qualche anno più tardi, nel 1894, il dottor Basilio Bonardi si dichiarava convinto che il suolo della città di Lugano fosse oltremodo saturo di immondezze. Anch'egli coglieva il nesso tra la qualità delle acque dei pozzi e le insufficienze fognarie: «Oltre ad avvelenare — scriveva il medico — per disopra con le loro emanazioni asfissianti i grami ambienti, entro ai quali si accalca la massa del popolo, le fogne lasciano sfuggire, per di sotto attraverso alle loro mal costruite e mal riparate pareti, una certa parte del loro contenuto, la quale va con lentezza sì, ma sicuramente a scaricarsi nelle acque, che poi noi e il popolo nostro beviamo» [35, 46].

La drammatica consapevolezza della pessima qualità dell'acqua che la popolazione luganese consumava fu maggiormente messa in rilievo allorquando la si sottopose a analisi chimica. Solo allora il rapporto tra la potabilità delle acque e lo sviluppo delle malattie fu avvalorato da dati certi e non da semplici intuizioni. Lo studio fu eseguito nel 1887 dal chimico Giuseppe Brentani e dal dottor Alfredo Buzzi, i quali compendiarono i risultati analitici in un interessante opuscolo al quale vale la pena fare riferimento, anche perché vi troviamo testimoniata una situazione che, con le necessarie cautele, può essere generalizzata per altri centri e altre zone del Cantone.

Gli approvvigionamenti idrici della città avvenivano quasi esclusivamente attraverso i pozzi. Solo nel 1879 fu costruita una fontana alimentata da una piccola sorgente, detta di San Carlo, che sgorgava sotto la stazione ferroviaria e alcuni anni più tardi se ne attivò una seconda in piazza Riforma [37, 3]. I due studiosi condussero le loro analisi sulle acque dei 36 pozzi del centro città, di altri 5 pozzi situati a nord-est, dove sorgeva l'agglomerato di più recente costruzione, delle fontane pubbliche e delle sorgenti e infine su quelle del lago e del fiume Cassarate. Circa il metodo adottato, il Brentani e il Buzzi definirono un grado limite di purezza dell'acqua sulla base di determinati quantitativi di sostanze organiche.

Le analisi confermarono che le acque dei pozzi cittadini non rispondevano assolutamente ai necessari postulati igienici e di potabilità. Con queste parole i due studiosi commentarono gli esiti delle loro ricerche:

«Il presente studio ha stabilito in modo indiscutibile che le nostre acque potabili non presentano una composizione chimica costante, il che significa che elementi nuovi si uniscono continuamente ai preesistenti, passando dal sottosuolo nei pozzi, sia per effetto della pioggia, sia per le piene del lago, sia per filtrazione diretta, previo impregnamento del terreno; tanto più che un'intricata rete di canali percorre la città, trasportando al lago le immondizie e i rifiuti delle case, e che i canali stessi non sono cementati, anzi non hanno neppure un intonaco di calce. Se oggidì è dimostrato che nessun cemento resiste all'azione delle materie fecali in putrefazione, tanto che la filtrazione o presto o tardi si

Tabella 1 — Analisi chimica delle acque potabili in Lugano, 1887. [38]

RISULTATI ANALITICI

I° Gruppo — Pozzi della città

	Località	Reazione dell'acido nitroso	Acido nitrico per litro	Cloro per litro	Ammoniaca per litro	Materia organica per litro	Durezza in gradi idrotim.
		gr.	gr.	gr.	gr.	gr.	
1	Via Pessina N. 281 (P. Marianna)	0,00552	0,47040	0,21700	0,00082	0,05851	91,5
2	Via Pessina N. 281 (P. della Scala)	0,00315	0,22475	0,22100	0,00722	0,07433	69,5
3	Via Verla N. 89, croc. Cortogna	positiva	0,16677	0,18440	0,00089	0,09330	56,5
4	Vicolo di Nassa N. 117	negativa	0,15288	0,40120	traccie	0,07590	57,5
5	Vicolo Cieco N. 141	negativa	0,14994	0,18150	—	0,03163	49
6	Piazza del Grano N. 151	negativa	0,14700	0,42550	—	0,06167	74,5
7	Via del Commercio N. 106	positiva	0,13780	0,22694	traccie	0,06000	58
8	Via della Dogana N. 143	negativa	0,13260	0,22761	0,00013	0,04586	59
9	Piazza del Liceo N. 60	negativa	0,13520	0,06381	traccie	0,03795	45,5
10	Piazza del Liceo N. 62	positiva	0,12640	0,14184	0,00654	0,02846	56
11	Porticaccio N. 121 (P. della Form.)	negativa	0,11352	0,14340	0,00005	0,01581	32
12	Via Canova N. 158	negativa	0,11018	0,08708	0,00010	0,03480	47,5
13	Via Francesco Soave N. 294	negativa	0,10304	0,06843	traccie	0,02056	47,5
14	Via Capuccine N. 23	negativa	0,08820	0,05319	—	0,01581	55,5
15	Via Canova N. 164	negativa	0,08820	0,03400	traccie	0,03795	35
16	Via Nassa N. 371	positiva	0,07644	0,05248	0,00532	0,02688	34
17	Via Nassa N. 359	negativa	0,07150	0,08226	0,00230	0,03637	49
18	Via Nassa N. 374	positiva	0,06909	0,07659	—	0,05692	44
19	Via Capuccine N. 36	negativa	0,06615	0,04610	—	0,03000	40,5
20	Via Capuccine N. 22	negativa	0,06174	0,02836	—	0,03470	41
21	Via Pretorio Vecchio N. 111	negativa	0,05880	0,28368	—	0,01897	51
22	Via Sassello N. 342	negativa	0,05880	0,15957	0,00260	0,04111	37
23	Via Nassa N. 373	negativa	0,05586	0,02694	0,00005	0,03004	30
24	Via Nassa N. 396	negativa	0,05163	0,02836	traccie	0,02530	41,5
25	Via del Liceo N. 185	positiva	0,05145	0,03262	traccie	0,01423	27,5
26	Via Canova N. 257	negativa	0,04557	0,02836	traccie	0,01739	28
27	Via Cioccaro N. 333	positiva	0,04410	0,00851	traccie	0,06642	28
28	Via Pretorio N. 202	positiva	0,03822	0,00780	—	0,04586	64,5
29	Via Cattedrale N. 303	negativa	0,03704	0,01134	—	0,03637	32
30	Via Pessina N. 281 (Retrobottega)	negativa	0,03380	0,02480	traccie	0,07275	22,5
31	Piazza del Liceo N. 54	negativa	0,03234	0,02268	traccie	0,02538	26
32	Via dell'Ospitale N. 173	negativa	0,02293	0,01773	0,00010	0,01265	21,5
33	Via Massagno N. 12	0,0076	0,02205	0,03260	0,00260	0,06009	24
34	Via Pretorio N. 202 (P. Vecchio)	negativa	0,01852	0,01241	traccie	0,01265	22
35	Via Massagno N. 13	negativa	0,01352	0,01700	—	0,02688	31,5
36	Via Nassa N. 404	negativa	0,01352	0,00638	—	0,03160	16

Tabella 1 — Analisi chimica delle acque potabili in Lugano, 1887. [38]

RISULTATI ANALITICI

II° Gruppo — Pozzi N.E. Lugano

	Località	Reazione dell'acido nitroso	Acido nitrico per litro	Cloro per litro	Ammoniaca per litro	Materia organica per litro	Durezza in gradi idrotim.
			gr.	gr.	gr.	gr.	
37	Via Molino Nuovo (Villa Aloisia)	negativa	0,00852	0,00532	—	0,01265	14
38	Piazza Castello N. 225	negativa	0,00852	0,00567	—	0,03004	13
39	Via al Cimitero N. 472	negativa	0,00823	0,00551	0,00002	0,02224	17
40	Via al Cimitero N. 473	negativa	0,00411	0,00460	—	0,01423	17
41	Madonnetta N. 511	negativa	0,00764	0,00532	—	0,02370	13,5
	Pozzo artesiano N. 211	positiva	0,00661	0,00478	traccie	0,01581	11

III° Gruppo — Sorgenti e fontane pubbliche

42	Via Massagno N. 3	negativa	0,01905	0,01276	traccie	0,03600	15,5
43	Sorgente sopra Nassa N. 375	negativa	0,01470	0,01060	traccie	0,02214	17
44	Sorgente al Ronco N. 442	negativa	0,01366	0,01770	—	0,02925	22
45	Sorgente al Ronco N. 445	negativa	0,01300	0,00469	—	0,01027	10
46	Fontana pubblica in P. Riforma	negativa	0,01171	0,00638	traccie	0,01897	19
47	Sorgente in Sassa	negativa	0,00396	0,00638	—	0,01257	7,5
48	Fontanile degli Angioli	negativa	0,00265	0,00392	—	0,00948	9,5

Acque di lago e di fiume

49	Acqua di lago lungo il quai	negativa	0,00382	0,00354	0,00031	0,07275	12,5
50	Acqua del fiume Cassarate	negativa	traccie	0,00120	traccie	0,07583	10
51	Acqua di lago a 250 m. dalla riva	negativa	traccie	0,00177	traccie	0,03004	12

La temperatura delle acque è compresa solitamente fra gli 11° e 15° gradi centigradi.

Venne definita acqua potabile pura quella nella quale non fossero superati i seguenti indici massimi per litro:

— componenti solidi 0,10 gr.
— acido nitrico 0,005 gr.
— cloro 0,08 gr.
— materie organiche 0,05 gr.

Inoltre non dovevano assolutamente comparire nitriti e si tollerava una traccia appena percettibile di ammoniaca.

avvera, come non deve accadere nella nostra città, nella quale le fogne sono costrutte a dispetto dei più elementari principii dell'igiene?» [38, 30].

L'inquinamento investiva soprattutto i pozzi situati nel vecchio centro, quello cioè che era stato più a lungo abitato e dove l'acqua era particolarmente «cruda e pesante», e rivelò agli esami chimici la presenza di considerevoli dosi di sale da cucina, sostanza che derivava dalle materie fecali. Inoltre le condizioni delle riserve idriche nel sottosuolo non erano stazionarie, ma soggette ai mutamenti stagionali: periodi secchi o molto piovosi contribuivano infatti a peggiorare la già precaria situazione. Le acque di molti pozzi, ad esempio, si intorbidivano visibilmente in seguito a acquazzoni.

Sulla base di dati calcolati su un arco di tempo di dieci anni i due studiosi misero in rilievo le costanti comparse del tifo in città e la sua notevole incidenza sulla mortalità. Gli agenti eziologici del morbo erano in stretta connessione con le pessime condizioni igieniche cittadine: «le emanazioni putride dei cessi — scrivevano gli autori — delle cloache, degli scolatoj sono i veicoli più ordinarii del veleno tifico, ma può essere contenuto nelle acque potabili, in conseguenza di infiltrazioni» [38, 25].

I dati statistici parlavano chiaro: dal 1876 al 1885 la popolazione luganese, che ammontava a 6.200 abitanti, rimase pressochè stazionaria; si registrò infatti una natalità di 1.857 individui e una mortalità di 1.642; ciò che significava un indice di incremento medio di 21,5 individui all'anno. In questo periodo di tempo, pur non essendosi verificate in città manifestazioni epidemiche di tifo, ma solamente casi sporadici, furono notificati circa 450 casi, e in base a un indice di letalità calcolato intorno al 10%, i decessi furono 45, cioè il 2,75% della mortalità totale. Queste cifre erano estremamente elevate, soprattutto se raffrontate con le medie di altre città. «Bisogna pur confessarlo — scrivevano con toni di sconforto il Buzzi e il Brentani — abbenché il rossore ci salga alla fronte, che qui si muore per ileotifo [tifo addominale] presso a poco e forse anche più di quello che anni sono si moriva a Londra, a Bruxelles, a Francoforte, a Parigi» [38, 33]. Se la mortalità per tifo raggiungeva proporzioni intollerabili, anche quella per altre non precisate malattie infettive era notevole: 337 decessi nel decennio considerato, il 20,5% della mortalità totale. E bisogna tener conto che in questa cifra non erano state computate le morti per «catarri» gastro-enterici e enteriti che non dovevano essere poche e erano riconducibili spesso alle conseguenze nocive dell'assunzione di un'acqua insalubre.

2. LA MORBILITÀ

Gli andamenti della morbilità nel Canton Ticino nella prima metà dell'Ottocento sono direttamente riconducibili al quadro delle disagiate condizioni igieniche che si è delineato, nel cui ambito è possibile individuare un terreno estremamente favorevole allo sviluppo delle malattie in tutte le loro molteplici forme di manifestazione. La malattia come fenomeno sociale dunque, come un evento quotidianamente presente e con il quale occorreva coesistere e misurarsi assumendo sovente, in una vita scandita da tante ristrettezze, un atteggiamento di impotente fatalismo.

Non esistono per questo periodo dati statistici di rilievo sull'entità e l'incidenza delle affezioni morbose, per cui ci si deve attenere a frammentarie e generiche testimonianze; in particolare ancora a quelle del Ghiringhelli e del Franscini. Il Ghiringhelli poneva al primo posto per la frequenza delle manifestazioni e l'elevato numero delle vittime le febbri «intermittenti», ma notava anche che le febbri «settiche» non erano rare e quelle «acute» uccidevano ogni anno un gran numero di individui. È necessario rilevare come parte della terminologia medica dell'epoca sia oggi di difficile lettura. Alcune espressioni restano per noi misteriose e non consentono di individuare la natura della malattia osservata. Un'affezione veniva definita sovente in base a dei semplici sintomi o in riferimento alle classificazioni derivate dalle principali scuole mediche dell'epoca. Spesso però dietro a questo tipo di nomenclatura si cela un'ignoranza quasi totale da parte della scienza medica sulla reale indole, l'eziologia, cioè lo studio delle cause delle malattie, gli sviluppi di molte forme morbose; e ciò spiega anche le perplessità e i dubbi sul piano diagnostico e terapeutico [cfr. 34, 67-75].

Il Franscini attribuiva al vaiolo il triste primato di mietere «una moltitudine di tenere vite», non solo per le frequenti recrudescenze epidemiche, ma soprattutto per la sua costante presenza, per cui in certe regioni assumeva caratteri endemici. Il vaiolo continuò nel complesso a manifestarsi diffusamente nel Cantone anche dopo l'introduzione della legge sull'obbligatorietà della vaccinazione antivaiolosa. Tra le altre affezioni morbose con elevate medie di mortalità il Franscini citava i «mali di petto», le «tossi» e le «punture», che provocavano il decesso di «un'altra moltitudine di adulte ed anco robuste persone» [59, 1/180]. Rientrano in questa serie le polmoniti, le bronchiti e in genere le malattie delle vie respiratorie, provocate, secondo l'autore, dalle repentine variazioni climatiche stagionali e dall'inadeguatezza dell'abbigliamento. In certi periodi dell'anno la peripneumonia era talmente diffusa in Leventina e in altre località montane «da prendere l'aspetto di un contagio». Seguivano infine i funesti effetti endemici delle febbri malariche terzane e quartane che serpeggiavano in molti territori paludosi del Cantone e di cui si riferirà in seguito.

Accanto a questa morbilità, che potremmo definire ordinaria, si devono menzionare anche le violente manifestazioni epidemiche che a ondate regolari investivano una buona parte della popolazione ticinese con esiti tragici e desolanti. Si intende qui accennare all'incursione nel 1817-18 del tifo petecchiale che, proveniente dai limitrofi Stati italiani, penetrò in alcune località del Sottoceneri aggravando i già drammatici effetti delle carestie che travagliavano soprattutto le classi meno abbienti. Ma particolarmente dure furono le vicende legate alle epidemie di colera che interessarono quasi esclusivamente i due distretti sottocenerini suscitando, con elevati tassi di contagiosità e di letalità, manifestazioni di terrore e di panico collettivo. Il colera fece la sua prima apparizione nel Cantone nel 1836 e si ripresentò nuovamente nel 1849, nel 1854-55 e nel 1867.

Qualche notizia più dettagliata sulle malattie, anche se non corredata da dati numerici, può esserci fornita dai risultati di una statistica medica cantonale inaugurata nel 1858 e continuata in modo irregolare negli anni successivi. Purtroppo i dati del 1858 sono parziali poiché solo 50 medici, circa il 40% dei sanitari legalmente esercenti, risposero ai quesiti dell'inchiesta. Dallo spoglio dei rapporti si riuscì comunque a ottenere qualche indicazione di carattere generale.

Le affezioni morbose che nel corso dell'annata colpirono con maggior frequenza la popolazione furono soprattutto di carattere infiammatorio, interessanti in particolare l'apparato respiratorio (bronchiti, angine, pneumonie, catarri, ecc.) e quello digerente, con affezioni gastriche e enteriche accompagnate spesso da eruzioni cutanee «quali sarebbero la rosilia, il morbillo, la miliare e la scarlattina, non escluso il vaiuolo e qualche raro caso di petecchia» [9, 1858/152-3]. Per quanto riguarda l'incidenza di altre malattie una porzione notevole era costituita dalle reumatiche e dalle artritiche, le cui cause erano riconducibili a particolari condizioni di lavoro o all'umidità di molte abitazioni. Anche il tifo serpeggiò diffusamente nel paese e in certe zone in proporzioni tali da far temere un'epidemia. Epidemicamente comunque si svilupparono una «grippe» che interessò quasi tutto il territorio del Cantone e, circoscritte ad alcune regioni, la «tosse ferina» e la dissenteria, quest'ultima da attribuire alla cattiva qualità dell'alimentazione. Tra le malattie contagiose furono notificate solo un'infezione scabbiosa e una sifilitica, e non mancarono le consuete manifestazioni di vaiolo sporadico che in alcune località raggiunsero comunque proporzioni preoccupanti. Le autorità erano infine propense a classificare tra le endemie anche la tubercolosi che, con le sue molteplici forme come la tisi, la scrofola, la rachiasi, risultava nel paese più diffusa di quanto generalmente non si pensasse, al punto da giustificare l'affermazione che la definiva un «flagello degeneratore della razza umana». In particolar modo sembra che nel secolo scorso le peculiari condizioni igieniche e fisico-ambientali di Vogorno nel Verzaschese alimentassero facilmente la scrofola e quelle di Losone la tisi polmonare. Di natura essenzialmente endemica erano considerati il gozzo, il cretinismo e l'idiozia, circoscritti soprattutto alle regioni della grande vallata del fiume Ticino.

Nelle contrade dove dominava il gozzo endemico la popolazione era esposta ancor più gravemente all'azione delle febbri malariche, soprattutto nel Piano di Magadino, vasta landa paludosa che, a causa delle frequenti fuoriuscite del fiume Ticino, era da considerarsi tra le più desolate e depresse del Cantone. Già il Franscini aveva fatto oggetto di studio il misero tenore di vita degli abitanti dei comuni circostanti il piano, la cui precaria situazione e la continua esposizione all'azione delle febbri, poneva in termini concreti il problema di un loro costante e precoce deperimento fisico.

Nei primi decenni del secolo non si era ancora colta l'origine infettiva anofelica delle febbri malariche, e anche il Franscini ne addebitava le cause all'insalubrità dell'aria corrotta dai «miasmi» che si sviluppavano dal terreno paludoso. I dati statistici delle sue osservazioni furono compendiati nel 1839 in una memoria resa pubblica durante una riunione della Società Ticinese d'Utilità Pubblica. Basti qui notare che il numero degli abitanti degli otto comuni del piano rimase in un arco di tempo di 28 anni pressoché stazionario, mentre nel resto del Cantone la popolazione era aumentata nello stesso periodo con indici di incremento sensibili. Anche le cifre sulla durata della vita rispecchiavano le misere condizioni di esistenza dell'abitante di quella regione: su 960 individui che componevano la popolazione di 4 comuni del piano solo 8 superavano i 70 anni. Numero irrisorio se si pensa che su 1.660 abitanti di 4 comuni collinari 61 erano quelli che oltrepassavano quell'età. «Così accade — scriveva il Franscini — che nel Cantone in generale è una specie di meraviglia il centenario: ne' villaggi del

Piano è già un portento l'ottogenario e l'uomo a 70 anni è già decrepito». Del resto i funesti effetti della malaria non si ripercuotevano solo sugli abitanti del piano, ma coinvolgevano pure quegli individui residenti nelle regioni collinari costretti a recarvisi per i lavori agricoli [58, 33].

Il Piano di Magadino non era la sola area dove nel secolo scorso dominava endemicamente la malaria. Nel 1904 il dottor Bruno Galli-Valerio aveva tracciato una precisa carta geografica delle zone paludose del Cantone che avevano rappresentato nel corso dell'Ottocento dei focolai malarici. Tra questi egli menzionava nel Sopraceneri il fondovalle della Maggia, della Verzasca, del Brenno e un lungo tratto di territorio costeggiante il fiume Ticino che dall'altezza di Lavorgo si estendeva fino a Bellinzona attraverso il distretto di Riviera e poi fino al Piano di Magadino. Nel Sottoceneri invece le regioni interessate erano nel Luganese il basso Vedeggio e la zona di Figino e nel Mendrisiotto il territorio di Ligornetto, Genestrerio, Novazzano e Stabio [63]. All'inizio del presente secolo la malaria continuava a serpeggiare, sebbene sporadicamente, solo sul Piano di Magadino, mentre nelle altre zone fu debellata sia attraverso i lavori di bonifica e di risanamento, sia attraverso l'uso generalizzato del chinino. Nonostante ciò il dottor Galli-Valerio aveva ancora individuato in tutti i focolai estinti o in via di estinzione larve di anofeli, per cui consigliava di proseguire ovunque i lavori di colmataggio per prosciugare i terreni acquitrinosi e le acque stagnanti, di agire profilatticamente distribuendo a basso prezzo il chinino e di distruggere col petrolio le larve.

Nella seconda metà del secolo si intensificarono gli sforzi per l'allestimento di statistiche mediche, nell'intento di pervenire a un controllo reale e sempre più effettivo sullo stato sanitario del paese.

Tabella 2 — Riepilogo generale delle malattie nel Cantone durante l'anno 1870. [9, 1870/106.]

A semplice titolo di esemplificazione documentaria riproduciamo la statistica medica riportata nel rendiconto governativo del 1870. Le indicazioni sono piuttosto rapide e generiche e anche in questo caso siamo confrontati con una terminologia medica di difficile interpretazione, che non ci aiuta a costruire un quadro preciso della morbilità.

Serie delle malattie	*Nome della serie*	*Casi*	*Morti*	*Guariti*	*In cura*
Serie I	Febri	10,239	623	9,144	472
Serie II	Cachessie	1,018	269	500	249
Serie III	Nevrosi	1,457	55	1,192	210
Serie IV	Ecrisi	1,465	149	1,279	37
Serie V	Vizi organici locali	984	36	829	119
Serie VI	Appendice	532	47	480	5
		15,695	1,179	13,424	1,092

Nel tessuto sociale del Ticino dell'Ottocento la malattia rappresentava sicuramente il sintomo più acuto di un malessere molto profondo che è possibile

intuire all'ombra di testimonianze spesso fugaci. Lo spazio maggiore veniva dedicato, nei documenti, ai morbi eccezionali, quelli che mietevano in breve tempo numerose vite e che, per il loro rapporto immediato con la morte, impressionavano e terrorizzavano i contemporanei. Sullo sfondo però esisteva una realtà di miseria, sulla quale si indugiava poco, forse perché ritenuta normale. Proprio da questa realtà scaturiva l'evento eccezionale. In altre parole, lo stato di salute della popolazione più povera non era solo minacciato dallo sviluppo di determinate malattie, ma anche da quei fattori di carattere economico e sociale, sicuramente meno appariscenti, che predisponevano a quella debolezza costituzionale, a quel deperimento fisico, a quell'aspetto malsano che diminuiva le possibilità di difesa dell'organismo dagli assalti morbosi.

Gli indici della mortalità infantile (sui quali torneremo più diffusamente nel capitolo successivo quando parleremo dell'assistenza ostetrica) erano particolarmente elevati. Basti considerare le numerose testimonianze sui gravosi lavori e le fatiche cui erano sottoposte le donne ticinesi anche durante i periodi di gestazione e che mettevano in serio rischio gli esiti di molti parti. Già il Bonstetten, nella sua relazione di viaggio, aveva notato che, a causa dell'emigrazione maschile, le donne che abitavano i baliaggi italiani servivano da bestie da soma, «ragione per cui illanguidiscono e invecchiano presto». Questa osservazione venne confermata pochi anni più tardi anche dal Ghiringhelli e verso la metà del secolo le autorità governative, preoccupate dalle tristi conseguenze che derivavano alla prole, denunciavano «il malvezzo delle donne pregnanti d'indurare in pesanti lavori fino agli ultimi momenti della gestazione» [9, 1855/192-3].

Se la mortalità alla nascita era molto elevata, non molto maggiori erano le probabilità di sopravvivenza durante il primo anno di vita, ridotte soprattutto dall'ambiente antiigienico in cui il neonato doveva trascorrere la maggior parte della sua giornata, dall'inadeguatezza di un'alimentazione in cui alla scarsità del latte materno si sopperiva troppo spesso con pappe e polte indigeste e di frequente dall'incuria dei genitori nei riguardi dei loro infanti. Così il Lurati riferisce della diffusa abitudine di nutrire i fanciulli nel periodo dell'allattamento, che durava spesso più di un anno, con pane premasticato e di quella delle mogli dei fittavoli del Mendrisiotto che in inverno trasferivano la culla nella stalla perché stesse al caldo [74, 81]. Non sorprende quindi se proprio le affezioni degli apparati digerente e respiratorio falcidiavano ogni anno un elevato numero di tenere vite. A quei tempi si aveva però una concezione diversa verso l'infanzia. La reazione al decesso di un figlio non era così intensa come oggi; la morte veniva anzi accettata con pronta rassegnazione e a volte, in mezzo a tanta miseria, con un certo sollievo. «Nelle famiglie di un tempo — scrive il Lurati — il neonato veniva spesso a pigliare il nome — e il posto — del bambino morto: i figli erano per così dire intercambiabili, non unici e insostituibili come oggi» [74, 81]. Questo tipo di atteggiamento fu ad esempio colto dal dottor Paolo Pellanda il quale, notificando nel 1849 lo sviluppo di una dissenteria sanguigna epidemica in alcuni comuni del Locarnese, sottolineava l'elevato numero di bambini che ne rimasero vittima soprattutto a causa della scarsa solerzia dei genitori nel sottoporli a cura medica. Il sanitario si chiedeva se ai genitori stesse veramente a cuore la guarigione dei figli o se preferissero piuttosto «di presto essere liberi d'un fastidio»; e concludeva: «v'ha qui della gente cui preme assai più la vita e la pro-

sperità del proprio bestiame che non della prole innocente» [1.1/730. Golino, 6.10.1849]. Le poche cure e attenzioni che in genere si prodigavano agli infanti erano sovente in relazione alla mancanza di tempo delle madri impegnate tutto il giorno nei lavori domestici e agricoli. Di regola si lasciavano gli infanti più piccoli in custodia a altri bambini «che a malapena si reggono da soli (...). È un vero caso — notava il Ghiringhelli — che ciò non provochi distorsioni, scottature, cadute, ecc. Quanti esempi si contano, di maiali che hanno morso, sbranato o comunque gravemente ferito bambini nella cuna!» [62, 59].

Terminato il periodo dello svezzamento il bambino veniva ben presto avviato ai più faticosi lavori campestri. Precoci occupazioni che spesso lasciavano una traccia permanente sulla loro costituzione fisica, determinando menomazioni e imperfezioni di sviluppo. Non sorprende dunque se anche la popolazione più giovane, quella che avrebbe dovuto apparire come la più sana e robusta, presentava invece generalizzati sintomi di debolezza. Ne abbiamo un'evidente conferma nell'elevato numero di individui che ogni anno venivano esonerati dall'obbligo di prestare servizio militare. Nel 1860, sebbene l'apposita commissione non avesse mancato di rigore nelle disamine dei casi, ben 782 furono gli scarti, cifra definita stragrande, soprattutto se si tiene conto che su un numero parziale di 686 reclute 164 furono dichiarate inabili al servizio, cioè il 23% circa. La maggior parte degli individui fu riformata per affezioni cardio-vascolari, varici, scrofola e tumori erniari. Le autorità propendevano a attribuire le cause di queste malformazioni proprio «alle eccessive fatiche cui vengono sottoposti in troppa tenera età i poveri ragazzi per l'avidità e per l'ignoranza dei loro genitori» [9, 1860/133].

3. LA MEDICINA E LA FARMACEUTICA DELLE CLASSI POPOLARI

Le pratiche di medicina popolare, la cui diffusione tra le popolazioni contadine ticinesi nel secolo scorso è largamente attestata, rimandano al contesto più generale di un'antica cultura popolare, i cui riflessi sono sopravvissuti e si sono conservati, spesso in modo sotterraneo attraverso i secoli. Se l'ambiente rurale conservatore, tradizionalista e poco permeabile alle novità, è stato indicato come un terreno ottimale per la conservazione e la trasmissione di valori, costumi e consuetudini antiche, nel caso del mondo popolare ticinese e più in generale delle popolazioni insediate lungo l'arco alpino e prealpino, siamo in presenza di specifici caratteri che possono essere compresi solo con uno sguardo storico retrospettivo.

«Nelle valli esterne dell'arco alpino — scrive il Gilardoni — sia in quelle impervie e chiuse ai traffici, sia negli abitati montani di quelle percorse dalle strade transalpine preromane e poi romane — le popolazioni vissero per secoli ai margini o, almeno, relativamente ai margini della storia. Della quale penetrarono le innovazioni che meglio si potevano adattare ai modi di vita dei luoghi, non i costumi, le idee, i modi di vita, i comportamenti sociali inconciliabili con le esigenze di quel mondo a sé che essenzialmente fu, nei millenni, per certi aspetti addirittura fino al secolo scorso, l'ambiente agropastorale subalpino» [65, 173].

In questa situazione di marginalità fu possibile conservare e tramandare una cultura autoctona [cfr. 66, 36 e nota 3], le cui origini si possono intuire ancora oggi, nonostante i numerosi tentativi di acculturazione che si intensificarono soprattutto nel periodo della Controriforma, attraverso la repressione delle devianze religiose e cultuali.

Si trattava di una cultura popolare semplice e elementare, caratterizzata da manifestazioni intuitive e da «modi di pensare, di sentire, di vivere, più vicini a quelli dell'uomo primitivo che dell'uomo «civile» dei borghi e dei centri cittadini» [65, 185].

La condizione di isolamento di cui si è detto era, in una certa misura, desiderata dalla popolazione e rispondeva a una fondamentale esigenza di difesa da influenze nuove, oscuramente avvertite come tarli che una volta insinuatisi avrebbero potuto in breve tempo minacciare equilibri consolidati e modi di vita acquisiti. Era questo un atteggiamento diffuso, che può trovare una conferma esemplificativa nel fatto che nei primi anni del secolo, quando la classe dirigente mise mano all'edificazione di una rete stradale che rispondesse alle esigenze della nuova configurazione politica e territoriale che il paese aveva assunto nel 1803, numerosi comuni avevano espresso il desiderio che le vie di comunicazione fossero tracciate a ragguardevole distanza dagli abitati, poiché, come ha osservato il Galli, era opinione generale che «le strade portassero i ladri» [62, 70 nota 70]. Espressione questa rivelatrice di un profondo senso di diffidenza verso tutto ciò che le vie di comunicazione avrebbero potuto condurre.

È in questo ambiente che, ancora nel corso dell'Ottocento, riaffioravano nelle credenze e nelle superstizioni le tracce di riti e culti appartenuti a un sapere remoto. In queste manifestazioni il Gilardoni ha individuato un profondo senso del sacro dell'uomo verso la natura, proprio di un atteggiamento nel quale i riferimenti alla magia e al soprannaturale intervengono per impossessarsi, comprendere e interpretare la realtà quotidiana.

Questo comportamento conoscitivo della natura e dell'ambiente coesisteva accanto all'impostazione vieppiù razionale e con pretese di scientificità di una cultura ufficiale, che si stava progressivamente affermando come l'unica valida. Così era, ad esempio, per la fede religiosa popolare, che presentò a lungo la contaminazione di culti profani e riti magici precristiani, che si erano amalgamati con le pratiche liturgiche ufficiali, nonostante le repressioni in passato da parte delle autorità ecclesiastiche.

Nel XIX secolo il mondo contadino ticinese era ancora popolato da spiriti, streghe e stregoni che, con il loro operato magico, originavano tutti quei fenomeni che ancora sfuggivano alla conoscenza e erano avvolti nel mistero. Così il Franscini nel 1837 osservava che il «villico» ticinese interpretava lo scoppio dei temporali o il manifestarsi di calamità che compromettevano l'esito dei raccolti agricoli non come «fenomeni ordinari della natura, ma opere de' maligni spiriti e degli stregoni». Per cui ogni volta che una tempesta si annunciava minacciosamente «si corre in chiesa, si espone il SS. Sagramento o qualche miracolosa reliquia e si viene sulla porta a benedire il tempo e a maledire gli spiriti fabbricatori della tempesta» [59, I/437]. L'autore assicurava anche che il «volgo» ticinese credeva che una moltitudine degli angeli seguaci di Lucifero, dopo essere stati cacciati dal cielo, fossero sulla terra per rimanervi fino al giorno del giudizio

universale; e che esercitavano il loro potere «durante la notte dal suono dell'Ave Maria della sera a quel della mattina» [59, I/443]. Negli stessi anni anche il conte Tullio Dandolo constatava che la superstizione era profondamente radicata tra la popolazione ticinese e scriveva: «dura tuttodì la credenza a' sortilegi. Lo spirito folletto vuolsi causa delle malattie de' fanciulli, delle epizoozie; de' temporali s'accusano gli stregoni» [50, 75].

Si deve tener presente che queste testimonianze e più in generale tutta la documentazione scritta dell'epoca, nella quale rinveniamo accenni alle credenze popolari, sono fonti parziali, a senso unico, che ci forniscono solamente i pensieri, le impressioni e i giudizi degli esponenti delle classi colte. Questi osservatori coevi erano mossi assai meno da una genuina volontà di comprensione, che da quella di gettare il discredito su usi di cui si accentuava il carattere ridicolo e irrazionale. Manca completamente la voce degli «altri», per lo meno nelle fonti scritte. Si avverte comunque la loro presenza, anche se in modo confuso; e se non ci si lascia irretire dai toni sovente deformanti di una documentazione di parte, si possono intuire determinati comportamenti sociali e il senso di certe credenze.

È nell'ambito del contesto culturale di cui si è tentato di fornire qualche indicazione, che vanno inserite anche le pratiche e i rimedi propri della medicina e della terapeutica popolare. Infatti nei suoi presupposti rinveniamo i riferimenti a una concezione della vita e della realtà in cui lo scongiuro del male e di ciò che opera maleficamente rappresentava senz'altro una necessità di primaria importanza. Nella mentalità popolare infatti la malattia non era una manifestazione patologicamente e eziologicamente definita, ma sfumava e si confondeva nella vasta categoria del male. La sua misteriosa causa era indubbiamente da ascrivere a un effetto di forze malefiche, che nell'immaginazione popolare si incarnavano spesso in persone capaci di produrre il male. Si reagiva quindi alle affezioni morbose ricorrendo alle forze benefiche e risanatrici. «Le malattie nervose — si legge in una pubblicazione del 1847 — (...) fanno credere ancora all'intervento di istregonerie, di folletti e di spiriti». Da ciò derivava «l'odio contro qualche innocente vecchierella, designata da qualche fattucchiera, quindi trascuranza di rimediare al male per mezzo della medicina, e non degli esorcismi e delle arcane parole passate in segreta eredità a qualche famiglia, a cui si ricorre inutilmente e con dispendiosi ed incomodi viaggi» [13, 1847/163-4].

Proprio per soddisfare un bisogno di difesa, per garantirsi dalle misteriose e avverse forze che popolavano il mondo rurale ticinese, la cultura popolare si era appropriata e aveva tramandato oralmente un ricco e secolare patrimonio di ricette, metodi di cura, pratiche propiziatorie e preservatrici, efficaci contro ogni genere di male, dai più semplici disturbi alle più gravi affezioni morbose, e nelle quali è possibile individuare costanti riferimenti di carattere magico e religioso.

In ogni collettività i bisogni sanitari venivano soddisfatti in modo autarchico e operavano individui che per le loro capacità e esperienze erano considerati i depositari di queste conoscenze terapeutiche e notoriamente indicati come i possessori di poteri speciali che permettevano loro di riconoscere il male e scongiurarlo. Tutti costoro erano pubblicamente rispettati dai membri della comunità, che con profonda devozione mettevano in pratica i loro suggerimenti e credevano ciecamente nelle loro virtù taumaturgiche.

Per i travagli del parto ci si rivolgeva ad esempio alla mammana, la quale agiva e consigliava in base alle consuetudini tradizionali. Così ancora verso la fine del secolo scorso si credeva che fosse indispensabile servirsi durante il parto di lenzuola già usate e si raccomandava alle puerpere di non cambiare la biancheria personale e del letto durante i primi otto giorni, se non volevano attirarsi qualche avversità. Le mammane fornivano anche ammaestramenti alle giovani madri sullo svezzamento dell'infante. Si proibiva ad esempio di tagliare al neonato i capelli e le unghie nei primi due anni, altrimenti non avrebbe più parlato; allo stesso modo non si doveva togliergli dal capo la «beretta», perché avrebbe potuto morire o gli si sarebbero offuscate le facoltà mentali. Se invece durante la gestazione si verificavano delle complicazioni o se durante lo svezzamento la madre scarseggiava di latte, allora si era in presenza di un maleficio che andava allontanato col potere di qualche guaritore. Similmente se il neonato presentava il segno del piede di capra vicino all'osso sacro, sarebbe diventato malvagio come il diavolo e si doveva condurlo subito dal prete per farlo benedire.

Anche per le malattie degli adulti si evitava di ricorrere al medico e ci si rivolgeva invece a guaritori, empirici e comari che apprestavano decotti, unguenti e panacee cui si attribuivano virtù veramente miracolose. Gli ingredienti di questi preparati, solitamente di origine animale o vegetale, furono inizialmente assunti in base a una loro azione terapeutica dedotta intuitivamente e che richiamava spesso, come ha notato il Coltro, le osservazioni proprie della «magia simpatica», in base alla quale il simile chiama il simile [47, 44].

Si era ad esempio convinti del passaggio magico della malattia dall'uomo che ne era affetto a un oggetto o un animale. Così il Lurati riferisce che per sanare il mal di pancia si usava adagiare sul ventre una pietra, poiché si credeva che il male sarebbe passato alla pietra e vi sarebbe morto [76, 79]. Sullo stesso principio si basava il rimedio per la cura delle malattie del capo, che prescriveva la collocazione sulla testa dell'ammalato di una gallina nera appena squartata. Esistevano ancora altre pratiche legate a questo tipo di credenze. Ne riportiamo a titolo di esempio alcune tra quelle raccolte da Vittore Pellandini all'inizio del presente secolo. La tosse asinina era guaribile somministrando al malato un topo arrostito; l'epilessia si curava invece ponendo sulla testa di chi ne era affetto «un uovo arrostito a dismisura che senta di bruciaticcio»; contro l'itterizia si usava far bere un uovo sbattuto contenente tre pidocchi; le infiammazioni dello stomaco si sanavano mangiando per otto giorni consecutivi al mattino e a digiuno tre lumache; la risipola invece andava unta con olio di mandorle, poi si applicava un sacchetto contenente farina di segale arrostita e una moneta d'argento; mentre le morsicature dei cani andavano medicate bagnando la parte offesa con una compressa intrisa di orina di bambini o delle donne vergini, sostanza quest'ultima alla quale, unitamente al latte materno e al mestruo, si attribuivano potenti virtù risanatrici [86, 43].

Quando la malattia appariva come l'effetto di un maleficio perpetrato da qualche strega, occorreva recarsi da un guaritore. Tra le diverse tipologie di cultori di medicina popolare nel secolo scorso era molto diffusa quella che il Lurati

classifica come «guaritore tradizionale di tipo rurale» [72, 3]. Le sue facoltà occulte si esplicavano nella forma dello scongiuro o del «segnare»; operazioni nelle quali preghiere, riti liturgici e formule religiose si confondevano con pratiche profane come l'uso di amuleti, di frasi misteriose e di sostanze particolari. Così nel mondo popolare ticinese un coacervo di elementi sacri, religiosi e profani convivevano pacificamente, sintetizzati nella vasta categoria del magico, dove all'operato dei guaritori, dei preti e dei santi protettori era riconosciuta una medesima valenza.

Alcuni anni fa i coniugi Lurati sulla base di alcune interviste a vecchi guaritori ancora attivi nel paese, hanno recuperato e descritto alcune interessanti pratiche. A Bedano un uomo «segnava» la sciatica per tre giorni consecutivi avvalendosi di olio e di una reliquia. In val Morobbia esisteva una vecchia in grado di guarire i dolori reumatici con uno scongiuro. Il procedimento era semplice: la donna si serviva di una paglia sulla quale aveva effettuato dei nodi e ripetendo una formula («l'osso febbrato voglio far tagliare, se volete tagliare tagliateli, in nome di Dio perché l'osso febbrato vada via») ne rompeva uno e si faceva il segno della croce. Anche in questo caso l'operazione andava ripetuta per tre giorni consecutivi. Nella val Cannobina, per citare ancora un esempio tra i molti riportati dai Lurati, vi erano alcune donne dette «strolégh» che curavano i vermi dei bambini intingendo alcuni fili di refe in un bicchiere d'acqua e poi li «segnavano». Se i fili affondavano voleva dire che il bambino era guarito. Nel 1845 un articolo apparso sull'«Almanacco del Popolo Ticinese» riferiva di un uomo che curava la risipola applicando sul corpo del malato una moneta d'argento e ripeteva per tre volte le seguenti parole: «Come Cristo fu legato alla colonna, così io lego questo male, che non possa andar più via». Costui era anche in grado di guarire i «mali naturali e soprannaturali» usando «carta pecora, agnus Dei, crocette di Gerusalemme, cinti, nastri, ecc.» [13, 1845/127]. Alla morte del guaritore i suoi poteri venivano trasmessi per discendenza a un figlio o a un parente stretto, in modo che si potessero perpetuare nel tempo.

Accanto ai guaritori esisteva anche una folta schiera di samaritani che senza far ricorso a specifici poteri, ma basando i propri interventi solo sull'esperienza, sopperivano alle lacune che contrassegnavano l'assistenza medica nel Cantone durante il secolo scorso. Si trattava dei conciaossa che medicavano fratture e slogature, delle stesse mammane, dei barbieri e dei flebotomi, che eseguivano semplici operazioni mediche come il salasso, le «fregagioni», l'applicazione delle coppette e la somministrazione dei purganti.

Un'altra grande categoria di guaritori depositari di poteri speciali erano i preti, che, oltre a «segnare» e a benedire, operavano anche con l'esorcismo: antica pratica rituale a metà strada tra magia e religione, nella quale le forze malefiche che provocavano la malattia si caratterizzavano più precisamente come una diretta manifestazione del demonio.

Gli esorcisti, mi riferisce un prete esorcista ancora attivo fino ad alcuni anni fa nel Cantone, erano un tempo molto diffusi, al punto da suscitare spesso interventi restrittivi da parte delle autorità ecclesiastiche, preoccupate degli slittamenti devianti rispetto al culto ufficiale cui queste pratiche potevano dar luogo. Per questo motivo i riti di esorcismo sono oggi severamente disciplinati dall'alto e possono essere effettuati solo da quei sacerdoti che, appurata l'efficacia dei loro poteri, hanno ottenuto una speciale dispensa vescovile. Le persone che oggi, come un tempo, ricorrono al prete esorcista avvertono dei disturbi, dei malesseri, bestemmiano e assumono atteggiamenti inconsueti, che sono interpretati come effetti di una possessione diabolica. Il demonio è infatti ovunque e ha dei coadiutori in grado di provocare il male. Durante il rito il sacerdote pronuncia speciali preghiere e usa oggetti come il crocefisso, l'acqua esorcizzata, l'olio e il sale. Dal canto suo la vittima della possessione demoniaca viene colta da una forte agitazione convulsiva, grida con voce artefatta, poiché è il diavolo che parla al suo posto. L'intervistato assicura che certe persone arrivano persino a arrampicarsi sui muri e a sollevarsi a mezz'aria. L'operazione va ripetuta finché il posseduto non viene liberato dalle forze malefiche. Queste pratiche comportano un grande dispendio di energie e oltre a ciò l'esorcista deve sempre stare in guardia poiché il demonio cerca sempre di vendicarsi delle sue virtù benefiche.

Si è detto che la medicina popolare era l'espressione di un patrimonio proprio del mondo rurale, ma si deve notare che il ricorso ai suoi rimedi era assai diffuso anche tra le classi popolari cittadine e in una certa misura tra i ceti più agiati. Il dottor Basilio Bonardi attestava che a Lugano verso la fine del secolo una larga parte della popolazione prestava ancora un'assoluta fede in molti rimedi della terapeutica popolare e aggiungeva che certe «costumanze non sono prerogativa del popolo, ma sono condivise e pur troppo praticate anche da una certa parte della classe benestante della cittadinanza». Il sanitario, sulla scia dell'opinione pubblica dell'epoca, ne addebitava le cause alla mancanza di cultura, all'ignoranza e alla superstizione dominante tra i cittadini e riteneva che «dove vi sarà maggior istruzione, ivi le popolari cognizioni di medicina maggiormente avranno perduto del carattere primordiale e si saranno avvicinate a un grado relativo di perfezione» [35, 40-1].

Ciò che maggiormente interessa tra le notizie forniteci dal Bonardi è l'affermazione sull'origine di molte pratiche terapeutiche popolari, che egli riconduceva a idee appartenute un tempo al sapere colto e che erano state in seguito invalidate da più recenti acquisizioni delle moderne discipline mediche. Queste conoscenze erano però sopravvissute più o meno integralmente nelle menti e nella cultura popolare. Questa origine è confermata anche dal Ceschi che ha sottolineato come i guaritori popolari fossero i «depositari di antiche pratiche di un sapere medico tradizionale, a volte confuso e sbiadito, a volte contaminato con elementi anacronistici della scienza medica illustre discesi per vie traverse e con sfasature di tempo nel circuito popolare» [43, 450]. È lo stesso autore a citare un esempio illuminante, osservando che nel 1800 il dottor Giuseppe Nessi, docente della R.I. Università di Pavia, consigliava come terapia efficace alla perdita dei sensi l'applicazione sulla testa degli ammalati di animali appena squartati, rimedio che solo qualche decennio più tardi era relegato al rango di stupida credenza popolare. La linea di demarcazione tra la terapeutica ufficiale e quella popolare era in realtà molto più sfumata di quanto si possa credere e tra i due ambiti potevano esistere reciproche ingerenze.

I rapidi mutamenti di indirizzi teorici e di metodi curativi stanno a dimostrare che ancora nell'Ottocento la medicina colta poggiava su postulati estremamente incerti e fragili, mancando alla disciplina un rigoroso supporto scientifi-

co. Particolarmente arretrate apparivano le nozioni intorno all'eziologia delle forme morbose, carenza che si ripercuoteva sull'attività terapeutica che era decisamente inadeguata e inefficace. La scienza medica dotta continuava insomma a basare i propri fondamenti teorici su astratti sistemi filosofici onnicomprensivi del funzionamento fisiologico dell'organismo umano, tanto fragili quanto slegati da ogni reale ricerca empirica. In assenza di uniformità di indirizzi e celando all'ombra di una ricca terminologia pseudoscientifica un desolante senso di impotenza, i sanitari procedevano per lo più per tentativi, intervenendo con rimedi effimeri e in molti casi contraddittori. Non sorprende quindi se, nonostante la retorica verbale di molti esponenti del ceto, la medicina ufficiale continuava a essere oggetto, soprattutto tra le classi popolari, di una grave mancanza di attendibilità, espressa da una profonda diffidenza che assunse sovente le forme di vera ostilità. Le popolazioni rurali ticinesi preferivano insomma i famigliari rimedi tramandati dalla tradizione e più confacenti alla loro mentalità; e comunque da un punto di vista terapeutico, per quanto riguarda cioè gli esiti delle cure e le guarigioni, si deve notare che la medicina colta non vantava successi sostanziali rispetto a quella popolare.

Nei primi anni del secolo scorso la classe dirigente ticinese avviò, seppur in modo discontinuo e frammentario, una politica sanitaria tendente a garantire al paese una più efficiente assistenza medica. Per conseguire questo obiettivo fu necessario emanare parallelamente una serie di disposizioni che prevedevano la completa esclusione dall'esercizio delle professioni sanitarie di tutti coloro che non avevano i necessari requisiti. Lo scopo era il conseguimento della definitiva professionalizzazione delle discipline sanitarie, attraverso l'eliminazione di ogni estranea ingerenza e dichiarando illegale l'operato di quei guaritori, di quelle comari e di quegli empirici nelle cui mani era tradizionalmente affidata la salute delle classi popolari. Il ceto medico esigeva insomma che gli fosse garantita l'esclusività nell'esercizio delle arti salutari. In questa lotta vennero assimilati senza distinzione ai tradizionali guaritori anche i numerosi imbroglioni e ciarlatani che durante il secolo scorso percorrevano le contrade del Cantone propinando in mala fede e a prezzi esosi rimedi prodigiosi atti a guarire ogni malattia e a mantenere sempre sani. Sotto la spinta della propaganda l'opinione pubblica colta dell'epoca cominciò a considerare tutti i samaritani popolari come una vera e propria peste della società. A proposito degli empirici così si esprimeva un articolista nel 1845:

«Non ci vuol molto a provare che tutti questi sono assassini del genere umano tanto più a temersi quanto più ci si presentano sotto le lusinghiere apparenze di amici e salvatori. Per curare le malattie conviene conoscerle; per conoscere le malattie è necessario avere studiato le leggi della vita; per sapere le leggi della vita è duopo avere lungamente investigato la struttura del corpo umano. (...) Ora come mai un ignorante, un incolto potrà esercitare la medicina? Per lo più codesti ciurmadori son tutti soggetti che, incapaci di professare altre arti, si mettono a fare il medico, quasiché la macchina del corpo umano sia la più facile ad essere conosciuta» [13, 1845/129-30].

Estremamente affilati e vibrati erano anche gli accenti sulle pratiche e i riti della medicina popolare, che vennero indiscriminatamente denunciati come stupide superstizioni e pregiudizi, frutto di ignoranza. In particolare venivano accentuati gli aspetti irrazionali e emotivi che maggiormente stridevano con le acquisizioni e i presupposti razionali del sapere colto. Occorreva quindi che il popolo fosse «incivilito» con un vasto programma educativo.

La progressiva promozione delle istituzioni mediche a ogni livello sociale, che si andava perseguendo in quegli anni, dovette però fare i conti con un'accanita resistenza popolare. Chiunque scorra il materiale documentario di questo periodo può farsi un'idea precisa dell'entità e dell'irriducibilità di queste opposizioni. I rapporti dei medici, degli ufficiali sanitari, dei commissari governativi che denunciano la passività della popolazione nel prestare fede alle raccomandazioni mediche e la frequenza con cui le leggi di polizia sanitaria venivano eluse e trasgredite, si susseguono in questi anni a ritmo incessante. In alcuni paesi i medici erano addirittura esposti a aperte minacce e a pressioni di ogni sorta; e più in generale la diffidenza si esplicitava nell'ostinato rifiuto di rivolgersi ai sanitari per farsi curare, nella scarsa solerzia con cui venivano approntate le necessarie misure precauzionali durante le epidemie e nella completa mancanza di rispetto verso le più raccomandate e elementari norme igieniche. Gli operatori sanitari e i metodi della medicina colta erano insomma troppo distanti dalle antiche pratiche terapeutiche popolari per essere assunti tout court. In questo modo la normativa sanitaria fu essenzialmente avvertita come un'imposizione che veniva a turbare dall'esterno il tradizionale ordine delle cose, le usanze e i costumi di sempre.

Nella prima metà del XIX secolo il medico si apprestava dunque a penetrare in modo esclusivo nel mondo popolare ticinese con tutto l'apparato delle conoscenze e dei metodi della medicina dotta. E non si trattava di un semplice processo di sostituzione: rimpiazzare cioè al vecchio guaritore il moderno sanitario, perché queste figure rappresentavano due diverse e poco conciliabili concezioni della malattia e dei modi per scongiurarla, espressione a loro volta di due culture e di due saperi profondamente differenti.